

RECURSO CÍVEL Nº 5086670-44.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIA DE MELLO BASTOS (AUTOR)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DO ENQUADRAMENTO DA DOENÇA DO AUTOR NO CONCEITO LEGAL DE ALGUMA PATOLOGIA ISENTIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CARDÍACA, MAS SEM INDICAÇÃO DO SEU GRAU A FIM DE AFERIR SEU ENQUADRAMENTO COMO GRAVE - ROL LEGAL TAXATIVO - NECESSIDADE DE SE ATESTAR E ENQUADRAR, DE MODO FUNDAMENTO E CIRCUNSTANCIADO, A PATOLOGIA DO AUTOR COMO GRAVE POR EXPERT NA MATÉRIA, ESPECIFICAMENTE PARA FINS DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA ATESTANDO O GRAU DA DOENÇA DO AUTOR A FIM DE ENQUADRÁ-LA COMO CARDIOPATIA GRAVE PARA FINS INSENTIVOS DO IMPOSTO DE RENDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, para determinar a produção de prova pericial sobre a parte autora e sobre a documentação médica apresentada com a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste (ou não) se ela é, ou já foi em algum momento de sua vida, portadora de cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda, nos termos da legislação de regência. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da nº 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5086670-44.2024.4.02.5101

510015640686 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5086670-44.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIA DE MELLO BASTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento do direito à isenção de IR sobre proventos de pensão bem como restituição de valores já pagos àquele título, sob a alegação de estar acometido de cardiopatia grave pois possui *"marcapasso e estando em tratamento desde 2014, estando em tratamento desde então e com a doença ativa tendo uma piora em seu quadro em janeiro deste ano."*

Apresentou documentação médica que apenas informa que a autora possui marcapasso desde 2014, além de outras doenças que não possuem relação coma a cardiopatia (evento 1, LAUDO6 e evento 1, LAUDO7).

O juízo de origem julgou **procedente o pedido**, pois considerou presente a comprovação idônea acerca da existência de cardiopatia grave. Eis os fundamentos da procedência do pedido:

"(...)

Os exames médicos apresentados pela parte no momento do ajuizamento da petição inicial atestam o fato de ser o autor portador de cardiopatia grave (CID I 10 , I 25.5), com implante de marcapasso com episódio de AVC isquêmico.

"(...)"

Em sede recursal, a Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença, ante a ausência de enquadramento categórico da patologia da parte autora no art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88.

É o relatório. Decido.

VOTO

A questão em tela passa pelo diagnóstico da doença e sua repercussão para fins de IR.

A exigência de prévio requerimento administrativo resta definitivamente afastada com a fixação de tese em de repercussão geral pelo STF em sentido contrário à sua exigência: "*O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.*" (**Tema 1373 - STF**).

No que tange à isenção de imposto por doença grave, limita-se a mesma à incidência do disposto no art. 6.º da Lei n.º 7.713/88, o qual preceitua nos seguintes termos:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os ***percebidos pelos portadores de*** moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, ***cardiopatia grave***, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)."GRIFOS NOSSOS

Consoante o disposto no art. 30 da Lei n.º 9.250/95, a comprovação da enfermidade que acarreta na isenção do imposto de renda deverá ser feita mediante **laudo pericial emitido por serviço médico oficial**, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Entretanto, o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que "*É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.*" (**Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017**).

Não consta dos autos laudo médico atestando a existência de cardiopatia grave ou parecer técnico do perito do juízo neste sentido. Tampouco os documentos médicos fazem menção específica à doença. O juízo entendeu que a mesma estaria presente tão somente com base da declaração médica do evento 1, LAUDO7:

SUMÁRIO DE ALTA

Paciente de 77 anos, previamente hipertensa, diabética não insulínica e portadora de marcapasso desde 2014 devido bradicardia sintomática, além de citar episódio de AVC isquêmico submetido a trombólise em janeiro de 2024. Interna no dia 07/07 com relato de no mesmo dia ter iniciado quadro súbito de fraqueza em MMII bilateral associado a disartria e vertigem. No momento da admissão, paciente encontrava-se sem déficit focal, força preservada, sem desvio de rima e mímica facial sem alterações. Interrogada a possibilidade de AIT e iniciado investigação. Ecocardiograma de 05/2024 sem alterações, ECG em ritmo adequado de marcapasso (revisão marcada para agosto de 2024 no HCPM), doppler de carótidas com acometimento aterosclerótico leve, duas tomografias de crânio sem alterações com o intervalo de 48h entre cada uma. Durante internação avaliada pela neurologia e fisiatria. Alta após resolução completa do quadro clínico com otimização medicamentosa e encaminhamento para seguimento ambulatorial nas especialidades.

É inegável que a parte autora possui problema cardíaco, mas nem todas as questões cardíacas podem ser tipificadas como **CARDIOPATIA GRAVE**, que é a doença que assegura a isenção. A conclusão exposta na II Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (<https://diretrizes.cardiol.online/>): *"É correta a afirmativa de Besser 46 de que **'É preciso não confundir gravidade de uma cardiopatia com Cardiopatia Grave, uma entidade médico-pericial'**. Essencialmente, a classificação de uma Cardiopatia Grave não é baseada em dados que caracterizam uma entidade clínica, e sim, nos aspectos de gravidade das cardiopatias, colocados em perspectiva com a capacidade de exercer as funções laborativas e suas relações como prognóstico de longo prazo e a sobrevivência do indivíduo. Verifica-se uma dificuldade ainda maior na extensão do benefício aos inativos (aposentados), já que estes indivíduos não mais exercem a atividade laborativa (esforço físico), um dos fatores considerados importantes no julgamento pericial de incapacitação. Embora os procedimentos intervencionistas e cirúrgicos sejam considerados na medicina pericial apenas parte da estratégia terapêutica aplicada aos doentes e, obviamente, não sejam considerados uma doença propriamente dita, sabemos que a cada intervenção corresponde uma enfermidade cardiovascular importante subjacente, que deverá ser avaliada em relação à ação deletéria e às deficiências funcionais que se possam imputar sobre a capacitação laboral do doente, como em todas as cardiopatias. Sabemos, também, que, num grande número de pacientes, a cirurgia ou o procedimento intervencionista alteram efetivamente a história natural da doença para melhor, modificando radicalmente a evolução de muitas doenças e, consequentemente, a categoria da gravidade da cardiopatia, pelo menos no momento da avaliação. Este é o conceito dinâmico de "reversibilidade" da evolução das cardiopatias, que deixam de configurar uma condição de Cardiopatia Grave observada anteriormente. De qualquer forma, nunca devemos achar, de antemão, que pacientes submetidos a quaisquer das intervenções mencionadas têm a condição médico-pericial de Cardiopatia Grave, como erroneamente interpretado por muitos. Considera-se um servidor (ativo ou inativo) como portador de Cardiopatia Grave, quando existir uma doença cardíaca que acarrete o total e definitivo impedimento das condições laborativas, existindo, implicitamente, uma expectativa de vida reduzida ou diminuída, baseando-se o avaliador na documentação e no diagnóstico da cardiopatia."*

Portanto, em que pese o quadro traçado pela documentação médica, não se sente este colegiado autorizado a concluir que o mesmo poderia ser categorizado como cardiopatia grave, em especial considerando que a parte autora sequer se sujeitou a perícia oficial nem apresentou outros documentos médicos e exames.

Sem o laudo médico pericial particular ou oficial atestando a cardiopatia grave, não é possível este colegiado aferir sua presença por mera presunção extraída das informações médicas prestadas, dado não ser o juiz expert na matéria técnico-pericial em análise. Ainda que se considere o quadro de saúde da autora grave, tanto que precisou passar por cirurgia, é imprescindível a confirmação técnica e expressa da patologia isentiva até porque o rol de doenças contido no dispositivo legal é **taxativo (numerus clausus)** a teor da interpretação que deve ser dada aos institutos conforme o CTN.

Portanto, a concessão de isenção se restringe às situações nele enumeradas, sendo que no caso presente seria exceção pois dar-se-ia por equiparação, na medida em que nenhum dos documentos mencionam a doença isentiva expressamente.

Entende-se, assim, que a sentença deve ser anulada, para que haja certificação médica do perito do juízo (profissional imparcial) quanto a efetiva presença de cardiopatia, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Este colegiado não desconhece o teor da Súmula 627 do STJ, mas entende que a prova dos autos não é suficientemente robusta para confirmar por si só a presença da moléstia grave isentiva.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA**, para determinar a produção de prova pericial sobre a parte autora e sobre a documentação médica apresentada com a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste (ou não) se ela é, ou já foi em algum momento de sua vida, portadora de cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda, nos termos da legislação de regência. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da nº 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5086670-44.2024.4.02.5101

510015640685 .V4